リハ医療デイリー

REHA MEDICAL DAILY

2026年10月24日（土）

第43号 朝刊

きょうの紙面 ▸ 多職種・自主練習 ▸ 制度・介護報酬 ▸ 心不全・フレイル ▸ 短信 8本

■ 多職種・自主練習

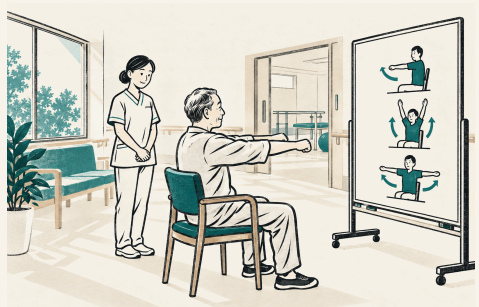
入院リハの自主練習「My Therapy」4職種で導入、職員88%が採用

患者278人・職員61人の監査。退院時FIMは変わらず、有害事象の報告なし

入院中の患者が訓練時間の外で自分から練習できれば、リハの量は増える。ただ、それを理学療法だけでなく病棟全体の仕組みにできるのかは別の問題だ。自主練習プログラム「My Therapy」を理学療法・作業療法・言語聴覚療法・音楽療法の4職種に導入し、RE-AIMの枠組みで評価した。

導入前、導入後、6か月後の3回の監査で、患者278人と看護・リハ職員61人のデータを集めた。作業療法と音楽療法では自主練習のプログラムを持つ患者の割合が有意に増え（p<0.001）、言語聴覚は早い時期に増え、理学療法は横ばいだった。看護師による自主練習の促しも増え（p<0.001）、職員の88%が採用し、4つの柱への忠実度も改善した（p<0.05）。

退院時のFIMは変わらず（p=0.681）、My Therapyに関連する有害事象の報告はなかった。同じ患者を追った比較ではなく、時点ごとの横断的な監査なので、ADLが上がったことを示す研究ではない。「自主練習を病棟の仕組みとして回せるか」を考える実例として読みたい。



広げられたかを見た実装研究。FIM改善の根拠ではない。

出典 Disability and Rehabilitation ↗

数字で見る

278人	88%	0.681
監査した患者	My Therapyを採用した職員	退院時FIMの変化（p値）

■ 制度・介護報酬

リハ3団体が介護報酬へ要望 17項目、重点8項目

リハビリテーション専門職団体協議会が、令和9年度の介護報酬改定に向けた要望書を10月15日に厚生労働省へ提出した。日本理学療法士協会が10月21日に公表し、POSTが内容を報じている。要望は全17項目で、うち8項目が重点だ。

報道によると、重点には特養併設のショートステイ利用後の状態悪化の予防、生活機能向上連携加算の対象拡大、処遇改善、物価動向を踏まえた報酬の引き上げ、ケアマネジャーとの同行訪問によるアセスメント加算の新設などが含まれる。訪問リハ関連は重点のうち4項目で、診察要件の見直しなどが挙がる。17項目の全文は会員限定部分にあり、個々の中身までは確かめられていない。



出典 POST（リハ職メディア） ↗

■ 心不全・フレイル

心不全の再入院を重ねるごとにフレイル・ADL・筋量が悪化

2016～2024年に心不全で初回入院し、その後に1回以上再入院した337人（延べ780入院、年齢中央値83歳、女性47.2%）を調べた。年齢・性で調整した混合効果モデルで、入院を重ねるにつれてClinical Frailty Scale（β=0.40）、Barthel Index（β=−4.21）、SPPB（β=−0.56、p=0.043）、骨格筋指数（β=−2.79）、握力（β=−4.64%）が悪化し、栄養指標のCONUTとGNRIも悪化した。



歩行速度の低下は有意ではなく（p=0.089）、MMSEも変化がなかった（p=0.501）。再入院できた人だけが対象の単施設の観察研究で、因果は言えない。退院時のADL・栄養・筋量の引き継ぎが大切になる結果だ。

出典 Circulation Journal ↗

短 信

〈失語症〉 **失語症者の地域医療、家族の役割**

失語症6人と家族5人の質的研究。受診は複雑でつらく、家族の支えが過小評価されていた。 出典 Disabil Rehabil ↗

〈実装〉 **ミラー療法と運動イメージの導入を評価**

OT16人の単施設評価。研修を受けた療法士は11→61%、患者への到達は月平均39%。 出典 Am J Occup Ther ↗

〈医療AI〉 **構音障害の重症度をAIで分類**

概念実証。実世界の音声でper-speaker F1 79%（67～100%）。STとのκは0.81～0.88。 出典 PLOS Digit Health ↗

〈整形〉 **肩関節置換術後、在宅リハは外来PTに非劣性**

RCT9本793人のSR。rTSAで1年の可動域・疼痛が同等。早期可動の利点は3か月で消えた。 出典 Shoulder Elbow ↗

〈ICU後〉 **ICU後の臓器移植患者にベッド上ゲーム**

26人の単群。227回中223回を完遂（98.2%）、中止に至る有害事象は0。効果は未検証。 出典 JMIR Serious Games ↗

〈心不全〉 **老健の心不全ケア、入所拒否の主因は薬剤費**

老健171施設の調査。入所拒否の49.7%が薬剤費、専門スタッフなしは99.4%。 出典 Circ J ↗

〈サルコペニア〉 **新基準で心不全の筋減少性肥満は13.6%に**

高齢の心不全589人。AWGS2019の7.8%から増えたが、予後の識別能は改善しなかった。 出典 Circ J ↗

〈評価〉 **腰椎X線のpsoas幅でサルコペニアを選別**

手術予定305人の後ろ向き。カットオフは男性118.8mm（AUC 0.847）、女性99.9mm（0.777）。 出典 JBJS ↗